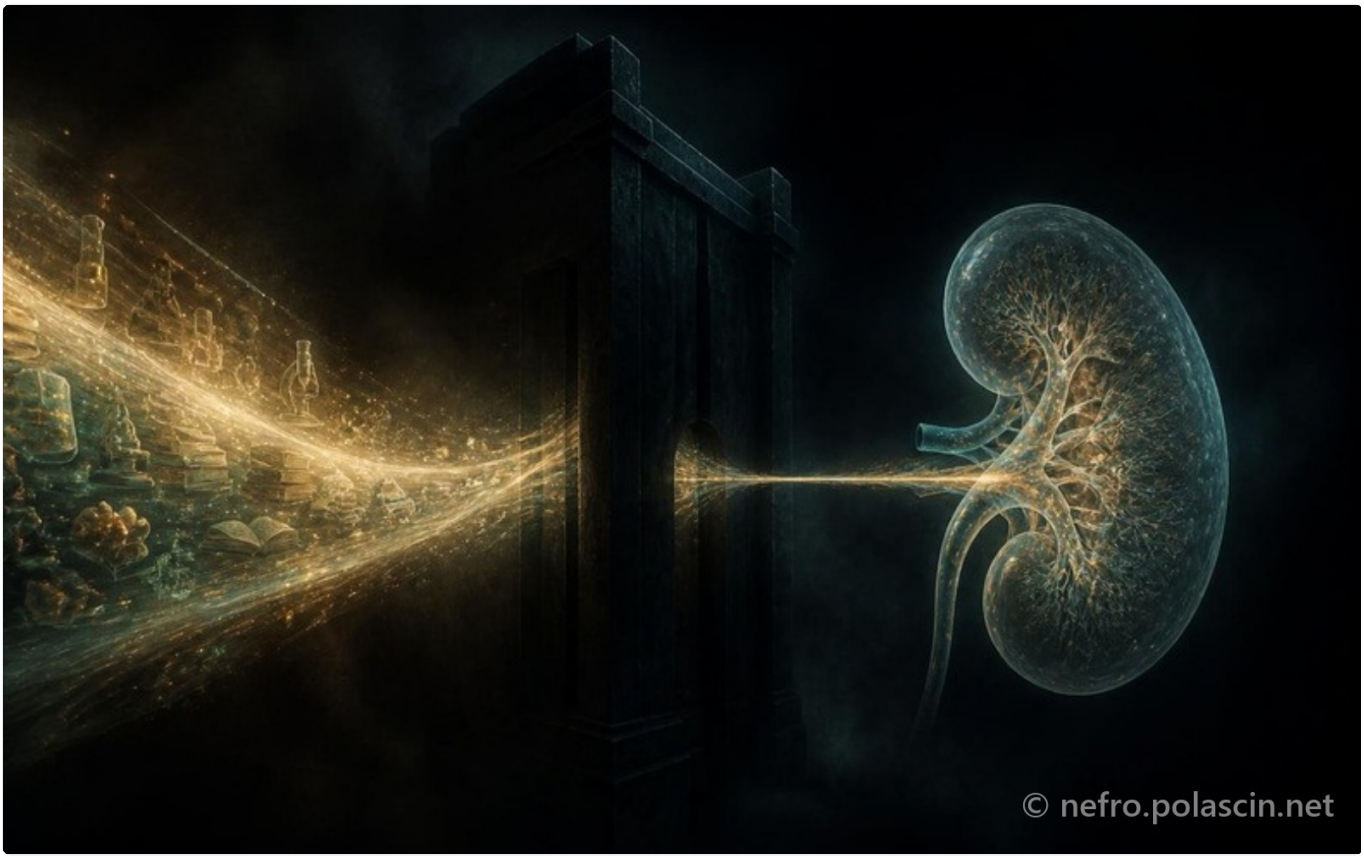
Nová ADA ako impulz na reflexiu: výskumné granty, politický zásah a dopad na nefrológiu

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 27.06.2026



Ilustračná scéna. Keď sa zúži financovanie výskumu, dôsledky sa prejavia až o roky – a nesie ich pacient.

Prečo je to relevantné pre nefrológiu

O klinickej nefrológii sa zvyčajne hovorí v rovine diagnóz, liečby a komplikácií. Veľa sa však rozhoduje aj mimo ambulancie: stabilita výskumného prostredia, dostupnosť grantov a schopnosť vedeckej komunity rýchlo prenášať výsledky do praxe. Diabetes mellitus, najmä jeho chronické mikrovaskulárne poškodenie, je pritom jedným z hlavných motorov chronickej choroby obličiek.

Článok na Medscape („The New ADA: I Prefer the Old One“) nie je klinický text. Ide o osobnú reflexiu a kritiku smerovania American Diabetes Association (ADA) v súvislosti s jej rozhodnutiami počas ADA Scientific Sessions. Pre nefrológa je zaujímavé najmä to, že autor spája konkrétne udalosti so širšou témou dopadov škrtov a politizácie výskumu na vývoj diabetologických a s nimi súvisiacich renálnych terapií.

Čo autor v texte opisuje

Irl B. Hirsch (MD) opisuje udalosti okolo ADA Scientific Sessions a svoj postoj k nim. V centre pozornosti sú podľa neho kroky vedenia ADA, ktoré viedli k odobratiu identifikačných kariet viacerým účastníkom. Autor to spája s distribúciou editoriálu (úvodníka) z časopisu *Diabetes Care* a s tým, že editoriál mal podľa jeho názoru komunikovať dopady škrtov v oblasti výskumu (NIH) na diabetologický výskumný „pipeline“.

Ako pozadie uvádza, že hlavným rečníkom (keynote) mal byť Jay Bhattacharya, ktorého napokon nahradil Richard Woychik. Text má aj širšiu politickú rovinu: priority a smerovanie výskumu.

Hlavná myšlienka: nejde len o jednorazovú konfliktnú situáciu

Autor nepíše len o jednom dni či o protokole podujatia. Tvrdí, že zásahy do výskumu a grantového prostredia

môžu mať dlhodobý účinok: spomalenie objavov, zníženie počtu projektov a posun priorít od základného a translačného výskumu ku krátkodobým alebo politicky „preferovaným“ smerom.

Pri chronických ochoreniach, ako je diabetes s renálnymi dôsledkami, je to podstatné, pretože výsledky z laboratória a klinických štúdií sa do praxe bežne dostávajú až s odstupom rokov.

Prepojenie na diabetologickú a nefrologickú prax

Aj keď text Medscape nie je primárne zameraný na nefrológiu, nefrologická komunita sa s dopadmi výskumného prostredia stretáva nepriamo:

- **Diabetická choroba obličiek:** pokrok v prevencii a liečbe CKD pri diabete stojí na výskume biomarkerov, mechanizmov progresie a na klinických skúšaniach.
- **Včasná intervencia a riziková stratifikácia:** ak sa zníži objem výskumu, môžu sa spomaliť aj inovácie v tom, ako identifikovať pacientov s rýchlou progresiou.
- **Dostupnosť dôkazov pre klinické odporúčania:** menej grantov môže znamenať menej kvalitných dát a pomalšiu aktualizáciu odporúčaní.

Ako čítať tento typ textu bez rizika nadinterpretácie

Ide o osobné stanovisko autora a opis udalostí z jeho pohľadu. Preto:

1. Tvrdenia, ktoré nie sú podložené nezávislými záznamami alebo formálnymi dokumentmi, nemožno automaticky považovať za overené fakty.
2. Ak má článok slúžiť ako podklad pre odbornú diskusiu, treba ho doplniť o primárne zdroje (vyhlásenia organizátorov, stanoviská, oficiálne recenzie a verejne dostupné informácie).

Praktické ponaučenie pre klinickú komunitu

Podľa autora by sa organizácia mala držať svojho poslania a udržiavať priestor pre vedeckú diskusiu. Pre nefrológiu z toho vyplýva praktická otázka, ako udržať:

- **stabilitu financovania výskumu** na dlhé obdobia,
- **ochranu akademickej slobody** a transparentnosť hodnotenia,
- **dôraz na poslanie** odborných spoločností a časopisov.

Ak sa tieto prvky oslabia, dopad sa časom prenesie aj do kvality dôkazov, ktoré používame v každodennej starostlivosti o pacientov s diabetickým aj nediabetickým poškodením obličiek.

Záver

Hirschov text kriticky hodnotí smerovanie ADA a zasadzuje ho do širšej otázky, ako môžu výskumné granty, politická klíma a rozhodnutia odborných organizácií formovať budúcnosť diabetológie a nepriamo aj nefrológie. Pre nefrológiu z toho vyplýva jednoduchá správa: stabilita výskumu nie je abstraktná téma, ale podmienka, aby sa nové poznatky včas premenili na lepšiu starostlivosť o ľudí s chronickou chorobou obličiek.

Poznámka k presnosti a overovaniu

Tento článok je prehľad a komentár vychádzajúci zo zdroja Medscape. Pri konkrétnych konfliktných tvrdeniach (kto, kedy a prečo konal) je rozumné overiť detaily v primárnych materiáloch organizácie a v nezávislých prehľadoch.

Zdroj: *Irl B. Hirsch, The New ADA: I Prefer the Old One, Medscape (2026).* *Link na zdroj.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=nova-ada-vyskumne-granty-politicky-zasah-dopad-na-nefrologiu · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.